

Icterícia neonatal · abordagem

Separe icterícia fisiológica de patológica pelo tempo de início, ritmo de subida e presença de sinais de alarme. Kernicterus é a complicação a evitar.

Quando é patológica

- Início < 24 h de vida
- Subida rápida (ex.: > 5 mg/dL/dia) ou nível muito alto
- Hepatoesplenomegalia, anemia, colúria/acalolia (pensar colestase se direta !)
- Sinais neurológicos: letargia, hipotonia, choro agudo

Causas de alto rendimento

Grupo | Exemplos

Hemólise | Incompatibilidade ABO/Rh, G6PD, esferocitose

Aumento entero-hepático | Baixa ingesta / desidratação, icterícia do leite materno

Hepática / colestase | Infecção, atresia de vias biliares (bilirrubina direta)

Outras | Hipotireoidismo, hematomas, sepse

Fototerapia

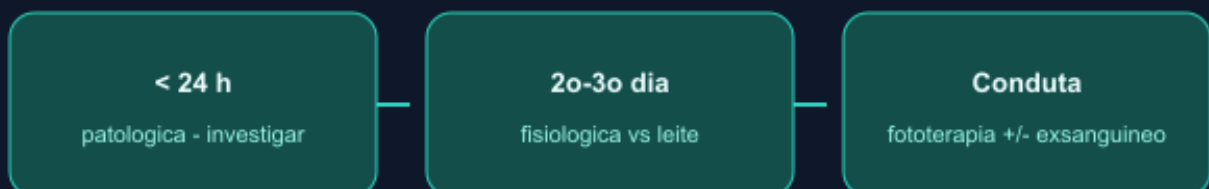
Dica - Fototerapia

Indicação pelo nomograma (idade em horas × fator de risco). Exsanguíneo-transfusão se níveis críticos ou sinais de encefalopatia bilirrubínica.

Início nas primeiras 24 h = patológica até prova em contrário.

Icterícia neonatal

Tempo de início guia a urgência



Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Icterícia com predomínio de bilirrubina direta não é 'fisiológica' e não se resolve só com fototerapia — investigue colestase (ex.: atresia biliar).

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1